



נוהל מס': 015.14
שם הנוהל: תיקון קרעים פרינאליים
התחום באקרידיטציה: לא רלבנטי

תפוצה	תחום הנוהל: נשים ומיילדות		תאריך פרסום: מהדורה: 1 תאריך עדכון:
	שם הנוהל: תיקון קרעים פריניאליים		
	כותב הנוהל: ד"ר איתמר נצר, פרופ' ליאור לבנשטיין		נספחים:
	מאשר הנוהל: פרופ' זאב וינר	האחראי על ביצוע הנוהל: פרופ' וינר זאב	
	על החתום:	על החתום:	
מס' דפים: 7			

תוכן העניינים

העמוד

הנושא

- | | |
|---|-----------------------|
| 2 | 1. רקע |
| 3 | 2. מטרות הנוהל |
| 3 | 3. הגדרות ומונחים |
| 3 | 4. סמכות ואחריות |
| 3 | 5. עקרונות הנוהל |
| 4 | 6. דיווח ותיעוד |
| 7 | 7. סימוכין (אסמכתאות) |

נוהל מס': 015.14
שם הנוהל: תיקון קרעים פריאנליים
התחום באקרידיטציה: לא רלבנטי



רקע:

קרעים פרינציפליים הנם סיבוך שכיח במהלך לידה נרתיקית, בין אם רגילה או מכשירנית. במרבית המקרים יוגדרו קרעים אלה כדרגה I המערבים את עור הפרינאום, או דרגה II הכוללים גם מבנים עמוקים יותר כגון שרירי רצפת האגן השטחיים, ללא מעורבות שרירי הסוגר של פי הטבעת. קרעים אלה ניתנים לתפירה בחדר לידה ואין להם בדרך כלל משמעות קלינית בהמשך החיים. אולם, במיעוט המקרים מערב הקרע את הספינקטר האנאלי, ומכונה קרע מדרגה שלישית או רביעית, או Obstetric Anal Sphincter Tear.

קרעים דרגה IV-III

שכיחות

שכיחות קרעים אלה בעולם משתנה ממדינה למדינה, ונעה בין אחוזים מדווחים נמוכים מאד (למשל 0.1% בסין או הודו) לאחוזים גבוהים יותר כגון 1.7% (2.9% למבכירות) במרכזים בעולם המערבי הנוקטים באפיזיוטומיה מדיולטרלית, ועד 12% (17% במבכירות) במרכזים הנוקטים באפיזיוטומיה מדיאלית. (1, 2). בישראל מדווח על שיעור נמוך של קרעים מסוג זה, כ- 0.25% (1-4).

גורמי סיכון

גורמי הסיכון הידועים כוללים: מבכירות (OR 2.4 – 5.8), מנח עורפי (Occipito-posterior) (OR 2.1 – 69.8) מוצא אסייתי (OR 8.9), לידת ואקום (OR 2.7), לידת מלקחיים (OR 3.3) ומשקל לידה גדול (OR 1.001 – 1.19). גורמי סיכון אפשריים נוספים כוללים פרע כתפיים ואלחוש אפידורלי (אף שקיימים מחקרים המצביעים על אפקט מגן של האחרון). (3) אפיזיוטומיה מדיאלית נחשבת לגורם סיכון לקרעים מסוג זה, (5, 6).

סיבוכים

על אף תיקון מיטבי, סיבוכיהם של קרעים מדרגה 3 ו-4 הנם אי נקיטה אנלית – מאי נקיטת גזים, דרך אי נקיטת נוזלים ועד לאי נקיטת מוצקים. ייתכן וקיים קשר ישיר בין דרגת הקרע לחומרת הסיבוכים, אם כי קשר זה לא הודגם בכלל המחקרים. זה ליו וחבריו דיווחו כי קיימת עלייה פי שתיים בסיכוי להתפתחות אי נקיטה אנאלית במעבר בין דרגות (3a > 3b > 4) (7). טווח הדיווח במחקרים השונים רחב ונע בין אחוזים בודדים לשיעור של יותר ממחצית הנשים; ככל הנראה שיעור אי נקיטת גזים בלבד הנו כ-15

נוהל מס': 015.14
שם הנוהל: תיקון קרעים פרינאליים
התחום באקרידיטציה: לא רלבנטי



60%, בעוד ששיעור אי נקיטת נוזלים ומוצקים הנו נמוך יותר, 2-29%. דחיפות בצאייה עשויה לפגוע ב-28-6 נוספים מהנשים. כמו כן, ייתכן שחלק מהנשים יחוו אי נקיטה אנאלית בזמן משגל. (שכיחות כ-19%). (3, 5, 6).

מטרות הנוהל:

להגדיר כיצד יש לזהות ולתקן קרעים פרינאליים מדרגה 3 ו-4.

הגדרות:

סיווג הקרעים :

ללא קרע: הפרינאום שלם.

קרע דרגה 1: קרע בעור הפרינאום בלבד.

קרע דרגה 2: קרע בפרינאום המערב את השרירים השטחיים של רצפת האגן אך לא את שרירי הסוגר של פי הטבעת.

קרע דרגה 3: קרע בפרינאום המערב את שרירי הסוגר של פי הטבעת בדרגות שונות:

קרע 3a: מערב את שריר הסוגר החיצון בעומק הקטן מ-50% מעוביו.

קרע 3b: קרע המערב את שריר הסוגר החיצון בעומק הגדול מ-50% מעוביו.

קרע 3c: מערב את שריר הסוגר החיצון ושריר הסוגר הפנימי.

קרע דרגה 4: קרע בפרינאום המערב את שרירי הסוגר של פי הטבעת ואת רירית פי הטבעת.

סמכות ואחריות:

רופאי מחלקת נשים ויולדות ורופאי מחלקה כירורגית אשר הוסמכו על ידי מנהל המחלקה שלהם.

עקרונות הנוהל:

זיהוי:

זיהוי דרגת הקרע מתבצע לפני התיקון באמצעות בדיקה רקטלית, בכל מקרה של אפיזיוטומיה או קרע פרינאלי. הבדיקה נעשית בצורה בימנאלית ע"י החדרת אצבע לפי הטבעת ומישוש הספינקטר באגודל של אותה יד, כשאצבעות היד השנייה מספקות חשיפה של האזור ע"י הרחבת פתח הנרתיק (7).

מהלך פעולה:

מומלץ לבצע תיקון קרעים מדרגה 3 או 4 בחדר ניתוח, בנוכחות ציוד ותאורה מתאימים, והרדמה אשר תספק הרפיה לשרירי פי הטבעת. לפי שיקול דעת המנתח ניתן לבצע את התפירה בחדר לידה. התיקון יבוצע על ידי רופא אשר הוכשר לכך והוסמך ע"י מנהל החטיבה לביצוע תיקון קרעים אלה.

נוהל מס': 015.14
שם הנוהל: תיקון קרעים פריאנליים
התחום באקרידיטציה: לא רלבנטי



טכניקת התפירה הנה מחוץ לטווח העיסוק של נוהל זה.

המשך טיפול במחלקה לאחר התיקון:

אנטיביוטיקה: יש לתת אנטיביוטיקה תוך ורידית רחבת טווח (Ceftriaxone & Metronidazol) במהלך הפעולה ובמשך 48 שעות לאחריה, ולהמשיך מתן אנטיביוטיקה פומית במשך 5 ימים נוספים. (3), (8).

יש לתת ביומיים הראשונים:

IV Flagyl 500mg*3/d; IV Rocephin 1gr*1/d

ובמשך 5 ימים נוספים:

PO Flagyl 500mg*3/d, PO Zinnat 500 mg*2/d

צנתור השלפוחית: ידוע כי טראומה פרינאלית במיוחד לאחר לידה מכשירנית הנה גורם סיכון לאצירת שתן. ניתן לצנתר את השלפוחית ליממה הראשונה לאחר הניתוח, במקרים בהם יש בצקת באזור הפות וקיים חשש שהיולדת תסבול מקושי בריקון שלפוחית השתן. חשוב לציין כי שארית שתן גדולה עלולה לגרום להרחבת יתר של השלפוחית ובהמשך פגיעה תפקודית. (3)

כלכלה ומניעת יציאות: באופן מסורתי נהוגות המלצות שונות החל מיצירה מכוונת של עצירות ועד למתן משלשלים מהיום הראשון לאחר התיקון. הספרות העדכנית תומכת במניעת עצירות ומתן משלשלים שכן נמצא כי כך ניתן להפחית כאב בזמן הצאייה הראשונה ולמנוע דחיסת צואה (fecal impaction) אשר עשויה לפגוע בתוצאות התיקון.

מומלץ לתת לקטלון 15 סמ"ק פעמיים ביום למשך 7-10 ימים. (3, 9).

תיעוד ודיווח:

יש לתעד במכתב השחרור את דרגת הקרע, ואת הטיפול שניתן בזמן האשפוז. יש להפנות את היולדת להמשך טיפול ומעקב ע"י רופא נשים בקהילה ומרפאת סוגרים, לפי הצורך.

אופן לידה עתידי

אופן הלידה העתידי תלוי בתסמינים של אי נקיטת צואה, דרגת הקרע בלידה הקודמת, גורמי הסיכון הנוכחים בלידה הקודמת והנוכחית, ובבדיקות עזר.

הסיכוי של קרע חוזר באישה לאחר קרע דרגה 3-4 בלידה קודמת הנו 4-7%. קרע חוזר מגדיל את הסיכוי של נשים אסימפטומטיות להפוך לסימפטומטיות. ביום שחרור היולדת מהמחלקה לא ניתן להתרשם מתפקוד הסוגרים מאחר ותהליך האיחוי של השרירים ורקמות החיבור לא הושלם. בשל היעדר נתונים אודות תפקוד הסוגרים לא ניתן להמליץ על צורת היילוד העתידי ביום השחרור מהמחלקה.

מקורות

1. Dudding TC, Vaizey CJ, Kamm MA.
Obstetric anal sphincter injury: incidence, risk factors, and management.
Ann Surg. 2008 Feb;247(2):224-37.
2. Groutz A, Hasson J, Wengier A, Gold R, Skornick-Rapaport A, Lessing JB, Gordon D.
Third- and fourth-degree perineal tears: prevalence and risk factors in the third millennium.
Am J Obstet Gynecol. 2011 Apr;204(4):347.e1-4.
3. Sultan AH, Thacker R. Perineal and Sphincter Trauma Diagnosis and Clinical Management. In: Sultan AH, Thakar R., Fenner DE (Eds.) 2007.
4. Hirayama F. et al. Prevalence and risk factors for third- and fourth-degree perineal lacerations during vaginal delivery: a multi-country study. BJOG
Volume 119, Issue Pages i–ii, 263–387
5. Eskandar O¹, Shet D. Risk factors for 3rd and 4th degree perineal tear. J Obstet Gynaecol. 2009 Feb;29(2):119-22
6. De Leeuw JW et al. Risk factors for third degree perineal ruptures during delivery British Journal of Obstetrics and Gynaecology. Volume 108, Issue 4, April 2001, Pages 383–387
7. The Management of Third and Fourth Degree Perineal Tears.
RCOG. Green-top Guideline No. 29, March 2007.
8. Buppasiri P, Lumbiganon P, Thinkhamrop J, Thinkhamrop B.
Antibiotic prophylaxis for third- and fourth-degree perineal tear during vaginal birth.
Cochrane Database Syst Rev. 2010 Nov 10;(11):CD005125.
9. Aasheim V, Nilsen AB, Lukasse M, Reinart LM.
Perineal techniques during the second stage of labour for reducing perineal trauma.
Cochrane Database Syst Rev. 2011 Dec 7;(12):CD006672.

נוהל מס': 015.14
שם הנוהל: תיקון קרעים פריאנליים
התחום באקרידיטציה: לא רלבנטי



**רמב"ם הקריה הרפואית
לבריאות האדם**

10. Aigmueller T, Umek W, Elenskaia K, Frudinger A, Pfeifer J, Helmer H, Huemer H, Tammaa A, van der Kleyn M, Tamussino K, Koelle D; Austrian Urogynecology Working Group.
Guidelines for the management of third and fourth degree perineal tears after vaginal birth from the Austrian Urogynecology Working Group.
Int Urogynecol J. 2013 Apr;24(4):553-8.